

1

治療前のポイント

ベースライン評価とリスクの見極め

1 確認すべきリスク因子



年齢(65～79歳は中等度、80歳以上は高リスクの一因)



既存の心疾患(心不全・虚血性心疾患・弁膜症など)



高血圧・糖尿病(コントロール状況を含めて)



放射線治療歴(特に心臓を含む胸部への照射)



心毒性のある治療歴(アントラサイクリン・トラスツズマブ等)

2 リスク区分の目安(HFA-ICOS)

低

中

高

非常に高

因子なし～軽度1つ

中等度 2～4点

5点以上/高因子1つ

非常に高因子1つ

例:LVEF 50～54%は中等度因子、LVEF 50%未満は高リスク因子、心不全・CTRCDの既往は非常に高リスク因子

3 ベースライン検査と基準値



心エコー:LVEF(左室駆出率)・GLS(より早期の指標)



トロポニン:hs-cTnTで14ng/L超、hs-cTnIで15～40ng/L超(測定法による)で上昇と判断



NT-proBNP ≥ 125 pg/mL、BNP ≥ 35 pg/mL(ナトリウム利尿ペプチド)

4 薬剤師のチェックポイント

- ☐ これから使う抗がん薬の心毒性プロファイルを確認する
- ☐ アントラサイクリンなら、換算後の累積投与量の起点を記録する
- ☐ 高リスク患者に心保護薬(ACE阻害薬・ β ブロッカー)の検討有無を確認する
- ☐ 高リスクの場合、循環器内科への紹介の有無を確認する

腫瘍循環器学(オンコカーディオロジー)研修シリーズ 実践ガイド 1/3(治療前) — ESC 2022 Cardio-Oncology Guidelinesに基づく